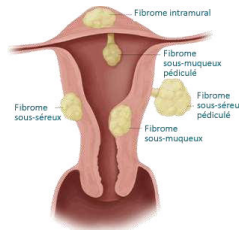


UTERUS CICATRICIEL

I. Introduction - définition

- On dit qu'un utérus est cicatriciel lorsqu'il comporte, en un endroit quelconque de l'isthme ou du corps, une ou plusieurs cicatrices myométriales
- Cette définition exclut donc:
 - Les cicatrices cervicales
 - Les cicatrices purement muqueuses (Synéchie)
 - Les cicatrices purement séreuses (myomectomie de fibrome sous-séreux pédiculé)



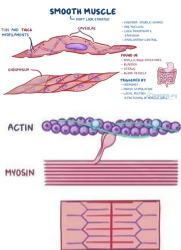
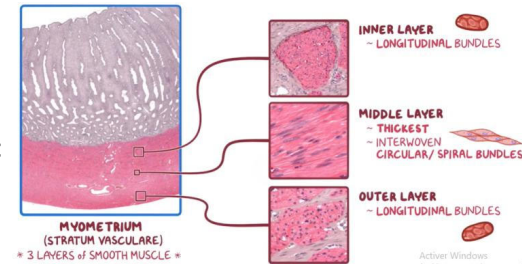
II. Epidémiologie

- Depuis les années 1970: la fréquence des utérus cicatriciels a augmenté dans la majorité des pays
- Taux les plus importants dans les pays industrialisés (USA: 12%-14%)

III. Cicatrice utérine

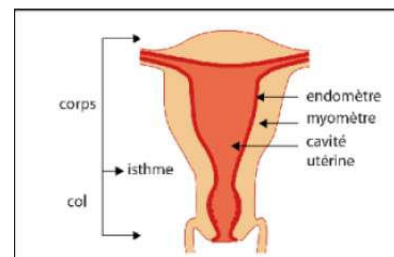
1. Etude histologique:

- Le muscle utérin est formé de trois plans de fibres musculaires lisses:
 - Un plan interne : paléo myomètre
 - Un plan moyen : néo myomètre
 - Un plan externe : péri ou paramyomètre
- La cellule musculaire : filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine
- Accrochage des têtes des filaments de myosine sur les filaments d'actine: déplacement et contraction musculaire sous la dépendance du Calcium intra cellulaire
- Le couplage entre les différentes cellules se fait par l'intermédiaire des gap-jonctions qui sont des canaux inter cellulaire
- ➔ **Propriété d'extensibilité et de contractilité**
- La section de ses fibres et les phénomènes de cicatrisation tissulaire se traduisent par une prolifération de tissu conjonctif avec infiltration fibroblastique et dépôts de fibrine
- La zone cicatricielle est constituée de tissu fibreux, parcouru de néo vaisseaux et de faisceaux musculaires lisses en quantité variable définissant sa qualité
- Lorsque les phénomènes d'inflammation, de hyalinisation, de prolifération fibroblastique et de fragmentation musculaire sont importants : la cicatrice est de mauvaise qualité



Type de cicatrice utérine:

- **Cicatrices obstétricales:**
 - ❖ Cicatrice corporelle: mauvaise qualité
 - ❖ Cicatrice segmentaire: bonne qualité
 - ❖ Cicatrice segmento-corporelle: mauvaise qualité
- **Cicatrices gynécologiques:**
 - ❖ Cicatrice de myomectomie: bonne qualité
 - ❖ Cicatrice d'hystéroplastie: bonne qualité
 - ❖ Cicatrice de résection de la portion interstitielle de la trompe: mauvaise qualité



2. Etude clinique et para clinique:

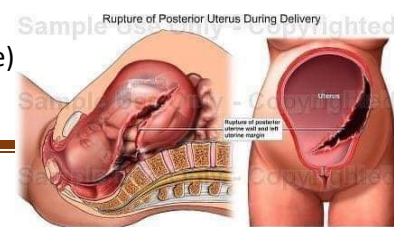
- **Toucher vaginal: aucun intérêt**
- **Echographie et hystérosonographie:**
 - En dehors de la grossesse: cicatrice facilement visible mais impossible de préjuger de la solidité de la cicatrice
 - Au cours de la grossesse: segment inférieur facilement visible mais mauvaise valeur prédictive positive sur le risque de rupture utérine



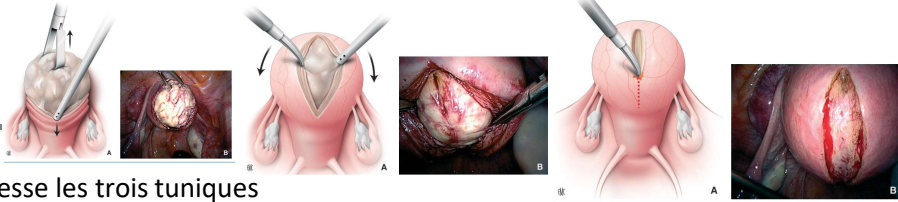
➔ **Echographie ne permet pas d'évaluer le risque de rupture utérine donc de choisir le mode d'accouchement**

3. Rupture de la cicatrice utérine:

- Solution de continuité intéressant la totalité de paroi (Muqueuse et musculeuse)
- Classification: 2 types



Facteurs favorisant la déhiscence sur utérus cicatriciel



QE!!

- Rupture utérine complète: intéresse les trois tuniques
- Déhiscence de la cicatrice: rupture incomplète sous péritonéale en général asymptomatique

IV. Grossesse et utérus cicatriciel

Complications de la grossesse

QE!!

Grossesse sur cicatrice de césarienne:

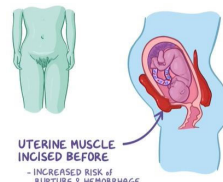
- Forme clinique extrêmement dangereuse, le risque de rupture utérine est considérable ainsi que les anomalies de placentation
- Les critères échographiques: Vacuité utérine, canal cervical libre, présence d'un sac gestationnel avec écho embryonnaire au niveau de la partie antérieure de l'isthme utérin, diminution de l'épaisseur du myomètre entre le sac gestationnel et la vessie

➔ Interruption de grossesse au premier trimestre

Anomalie de la placentation:

- Hématome rétro-placentaire : Risque accru
- Placenta Praevia : Risque 2 à 5 fois plus élevé
- Placenta Accreta : Pénétration anormale d'un ou plusieurs cotylédons dans la couche myométriale avec disparition de la caduque basale

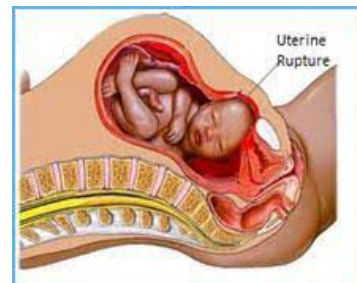
➔ Difficulté de la délivrance et hémorragies



PLACENTA PERCRETA :

- Risque de mort fœtale in utero x2
- Rupture utérine en cours de grossesse : cicatrice corporelle

RUPTURE UTERINE



V. Prise en charge d'un accouchement sur un utérus cicatriciel

1. Evaluer la qualité de la cicatrice utérine

a. Eléments relatifs à la patiente et ses antécédents:

- Age de la patiente, IMC
- Type d'incision
- Délai entre césarienne antérieure et nouvelle grossesse

b. Eléments relatifs à la grossesse en cours:

- Présentation
- Localisation placentaire
- Surdistension utérine

2. Césarienne prophylactique :

a. Indications liées à la première césarienne:

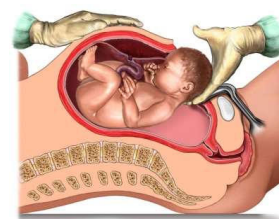
- Cicatrice corporelle
- Utérus doublement cicatriciel
- Antécédents de rupture utérine
- Cicatrice ségmento-corporelle

b. Indications liées à la grossesse actuelle:

- Macrosomie fœtale
- Grossesse gémellaire
- Anomalies de la filière génitale
- Bassin limite

- Antécédents d'accouchement par VB
- Indication de la césarienne antérieure
- Type de suture d'hystérotomie
- Suites post-opératoires

- Appréciation du bassin
- Examen du col à l'entrée en salle d'accouchement



- Présentation dystocique
- Présentation de siège
- Placenta accrète

3. Accouchement par voie basse : Epreuve de la cicatrice

a. Conditions de l'accouchement:

- Equipe qualifiée,
- Une seule cicatrice, Cicatrice segmentaire
- Pas de malformation utérine
- Pas de sur distension utérine
- Pas d'obstacle praevia
- Scano pélvimétrie systématique

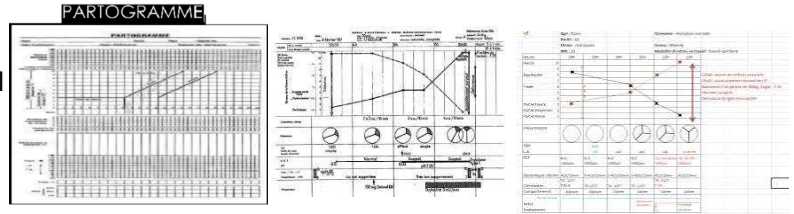
- Présentation céphalique
- Grossesse unique
- Placenta normalement inséré

b. Début du travail:

- Travail spontané de préférence
- Déclenchement du travail à éviter car risque de rupture utérine

c. Conduite du travail:

- Surveillance des contractions utérines
- Surveillance du rythme cardiaque foetal
- Partogramme
- Durée de l'épreuve utérine



d. Analgésie et utérus cicatriciel:

- Il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de l'anesthésie péridurale en cas de cicatrice utérine

e. Expulsion:

- Expressions utérines à proscrire
- Extractions instrumentales ne doivent pas être systématiques

f. Délivrance:

- Révision utérine n'est pas systématique en cas d'utérus cicatriciel

Conclusion

- ✓ Accouchement à risque de rupture utérine
- ✓ Surveillance stricte du travail : si accouchement par voie basse autorisé

MORE ON : INDICATIONS DE L'ACCOUCHEMENT PAR VH :

MATERNAL INDICATIONS

- PREVIOUS C-SECTION
- OBSTRUCTIVE LESIONS of the LOWER GENITAL TRACT
- TRANSMISSIBLE MATERNAL INFECTIONS
- PREEXISTING CARDIAC DISEASE

PREVIOUS C-SECTION



INDIVIDUAL w/ SINGLE PREVIOUS C-SECTION
- SINGLETON PREGNANCY
- CEPHALIC PRESENTATION
- NO UTERINE RUPTURE

VAGINAL DELIVERY IS SAFE

OBSTRUCTIVE LESIONS of the LOWER GENITAL TRACT

- CERVICAL or VAGINAL CANCER
- VULVOVAGINITIS, CONDYLOMAS
- OBSTRUCTIVE VAGINAL SEPTA
- LARGE UTERINE FIBROMAS

TRANSMISSIBLE MATERNAL INFECTIONS

- HIV
- HEPATITIS
- ACTIVE GENITAL HERPES
- At time of delivery or in last trimester

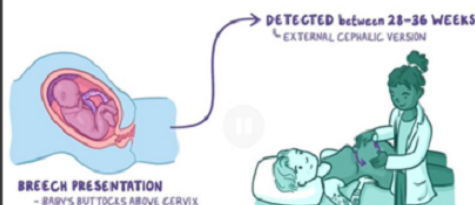
PREEXISTING CARDIAC CONDITIONS

- CARDIOMYOPATHY
- Prosthetic valves

FETAL INDICATIONS for C-SECTION

- ABNORMAL FETAL PRESENTATION
- CONGENITAL MALFORMATIONS or SKELETAL DISORDERS
- SIGNS of INFECTION

ABNORMAL FETAL PRESENTATION



CONGENITAL MALFORMATIONS

- GASTROSCHISIS
- ABDOMINAL ORGANS PROTRUDE out of ABDOMINAL CAVITY
- ↑ CHANCE of INFECTION

OTHER INDICATIONS for C-SECTION

CEPHALOPELVIC DISPROPORTION

- BABY TOO BIG for MOM'S PELVIS

PLACENTAL ABNORMALITIES

PLACENTA PRAE VIA



PLACENTA ACCRETA



C-SECTION by MATERNAL REQUEST

- * CONVENIENCE
- * POOR PRIOR VAGINAL DELIVERY EXPERIENCE
- * FEAR of PAIN & COMPLICATIONS of LABOR

C-SECTION on MATERNAL REQUEST is WIDELY ACCEPTED

- WELL-INFORMED of the RISKS & BENEFITS of VAGINAL & CESAREAN DELIVERY

PROS

~ FASTER RECOVERY

~ LESS PAIN

CONS

~ ↑ RISK of VAGINAL or PERINEAL TEARING

~ ↑ RISK of BLOOD LOSS & INFECTIONS
~ BOWEL or URINARY TRACT ACCIDENTALLY INJURED
~ RECOVERY TAKES LONGER
~ PAIN/SORENESS at INCISION & in LOWER ABDOMEN